LÝ THUYẾT · MẮT

BÀI 5 Bệnh glaucoma

Biên soạn lại từ bài giảng 5. Glaucoma - Diagnosis & Treatment.pdf (19 trang) · Giải thích dễ hiểu, kèm 7 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. SINH LÝ THỦY DỊCH
2. NHÃN ÁP
3. ĐẠI CƯƠNG VÀ PHÂN LOẠI
4. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC ĐÓNG
5. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC MỞ
6. GLAUCOMA BẨM SINH

Học xong bài này, bạn cần: trình bày được triệu chứng lâm sàng của glaucoma góc đóng và góc mở; phát hiện các triệu chứng đặc trưng của glaucoma; nêu được các phương pháp điều trị.

1. SINH LÝ THỦY DỊCH

- **Sản xuất: biểu mô ở nếp thể mi**.
- **Lưu thông: hậu phòng → lỗ đồng tử → tiền phòng**.
- **Thoát lưu: góc tiền phòng → lưới bè → ống Schlemm → tĩnh mạch thượng củng mạc**.
- **Vai trò: tạo nhãn áp**, tham gia **quang học**, **nuôi dưỡng** (giác mạc, TTT là những mô không có mạch máu).

Hình 1. Đường đi của thủy dịch: sinh ra ở thể mi, qua đồng tử ra tiền phòng, thoát ở góc tiền phòng qua lưới bè vào ống Schlemm.

Hiểu nhanh: hãy hình dung mắt như một **bồn rửa có vòi và lỗ thoát**. **Thể mi là vòi nước**, liên tục chảy ra thủy dịch; **góc tiền phòng với lưới bè là lỗ thoát**. Nhãn áp chỉ tăng khi nước chảy vào nhiều hơn nước thoát ra – mà trên thực tế, thủ phạm thường là **lỗ thoát bị tắc**.

2. NHÃN ÁP

- **Công thức Goldmann: Pio = D × R + Pv**
  - **Pio:** nhãn áp (**bình thường 10–21 mmHg**).
  - **D:** tốc độ sản xuất thủy dịch.
  - **R:** trở lưu thủy dịch (lỗ thoát khó hay dễ).
  - **Pv:** áp lực tĩnh mạch thượng củng mạc.
- **Lưu ý lâm sàng:**
  - **Đa số tăng nhãn áp là do tăng R** (cản trở thoát lưu), không phải do sản xuất quá nhiều.
  - Nhãn áp **dao động trong ngày, thường cao vào nửa đêm / sáng sớm**.
  - Vì vậy **cần đo nhãn áp nhiều lần trong ngày**; một lần đo bình thường chưa loại trừ được bệnh.
- **Nhãn áp kế:**
  - Nguyên lý **đè bẹt**: nhãn áp kế **Goldmann**, **Maclakov**.
  - Nguyên lý **ấn lõm**: nhãn áp kế **Schiotz**.

Hình 2. Hai nguyên lý đo nhãn áp: đè bẹt (Goldmann gắn trên sinh hiển vi) và ấn lõm (Schiotz đặt trên giác mạc bệnh nhân nằm).

3. ĐẠI CƯƠNG VÀ PHÂN LOẠI

- Glaucoma là **nguyên nhân gây mù đứng hàng thứ 2** (theo bài giảng: **đứng sau đái tháo đường**).
- Toàn cầu: **> 66,8 triệu người mắc** (năm 2000).
- **Ba đặc điểm chung:**
  - **Tăng nhãn áp** quá mức chịu đựng của mắt.
  - **Thị thần kinh: lõm và teo gai thị.**
  - **Thị trường: bị tổn hại nghiêm trọng.**

Hình 3. Gai thị bình thường (mũi tên), gai thị lõm teo do glaucoma và thị trường bị thu hẹp.

> **Vì sao glaucoma đáng sợ hơn đục thủy tinh thể?** Đục TTT mổ xong là nhìn lại được. Còn glaucoma phá hủy **sợi thần kinh thị giác** – phần thị lực đã mất **không lấy lại được**. Điều trị chỉ giữ cho bệnh **không nặng thêm**, nên phát hiện sớm là quan trọng nhất.

Loại	Đặc điểm
Nguyên phát	**Không kèm bệnh lý khác**; thường **bị 2 mắt**, có tính **di truyền**
Thứ phát	**Kèm bệnh mắt / toàn thân**, **do tác dụng thuốc**; thường **bị 1 mắt**
Bẩm sinh	Ở **sơ sinh**, do **bất thường góc tiền phòng**; sợ sáng, chảy nước mắt
Tuyệt đối	**Không đáp ứng điều trị**; **mất thị lực, đau nhức nhiều**

4. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC ĐÓNG

Dịch tễ và yếu tố nguy cơ

- **Chủng tộc:** da đen, **châu Á** (Mông Cổ, **Việt Nam**).
- **Giới: nữ >> nam**. **Tuổi:** lớn tuổi.
- **Cấu trúc mắt: tiền phòng nông, góc hẹp, viễn thị, trục nhãn cầu ngắn**.
- **Di truyền:** tiền căn gia đình có người mắc bệnh.
- **Yếu tố thúc đẩy cơn: căng thẳng (stress), lạnh, thuốc giãn đồng tử**.

Cơ chế

Hình 4. Cơ chế đóng góc: thủy dịch bị nghẽn ở đồng tử, ứ lại sau mống mắt, đẩy mống mắt phồng ra trước và bít góc tiền phòng.

- Ở mắt có **tiền phòng nông, góc hẹp**, mống mắt nằm rất sát TTT → thủy dịch khó đi qua lỗ đồng tử (**nghẽn đồng tử**).
- Thủy dịch **ứ lại ở hậu phòng**, đẩy mống mắt **phồng ra trước**.
- **Chân mống mắt áp vào lưới bè** → **góc tiền phòng đóng** → thủy dịch không thoát được → **nhãn áp tăng vọt**.

> **Vì sao thuốc giãn đồng tử, bóng tối, stress lại gây cơn?** Khi đồng tử giãn, mống mắt **co cụm dày lên ở chân mống**, đúng vị trí góc vốn đã hẹp → góc bị bít. Vì thế, với người có tiền phòng nông, **phải thận trọng khi nhỏ thuốc giãn đồng tử**.

Triệu chứng lâm sàng

- **Cơ năng:**
  - **Đỏ, đau, nhìn mờ.**
  - **Thấy quầng màu sắc** quanh bóng đèn.
  - **Buồn nôn và nôn ói**; hoa mắt.
- **Thực thể:**
  - **Giảm thị lực, nhãn áp cao.**
  - **Soi góc tiền phòng: góc đóng.**
  - **Kết mạc cương tụ rìa**; **giác mạc phù**; **tiền phòng nông**.
  - **Đồng tử giãn méo, phản xạ ánh sáng (–).**
  - **Gai thị cương tụ / lõm teo gai.**

Hình 5. Cơn glaucoma góc đóng cấp: giác mạc phù mờ, cương tụ rìa, đồng tử giãn; khe sáng cho thấy tiền phòng rất nông.

> **Vì sao thấy "quầng màu"?** Nhãn áp cao đẩy nước vào giác mạc làm **giác mạc phù**; ánh sáng đi qua giác mạc phù bị tán xạ thành **các vòng màu như cầu vồng** quanh bóng đèn. Nhãn áp quá cao còn làm thiếu máu cơ mống mắt → **đồng tử giãn, méo, mất phản xạ**.

Điều trị nội khoa

- **Mục tiêu: cắt cơn cấp**, **bảo vệ mắt còn lại**, điều trị **tạm thời chờ phẫu thuật**.
- **Toàn thân:**
  - **Thuốc ức chế men CA (CAIs)**: giảm sản xuất thủy dịch.
  - **Truyền tĩnh mạch đường ưu trương (Mannitol 20%)**: rút nước ra khỏi nhãn cầu.
  - **Giảm đau, an thần.**
- **Tại chỗ:**
  - **β-bloquant**, **α-agonist**: giảm sản xuất thủy dịch.
  - **Pilocarpin**: co đồng tử, kéo chân mống ra khỏi góc.
  - **Kháng viêm steroid.**

Điều trị ngoại khoa

- **Laser YAG cắt mống chu biên:** tạo một lỗ nhỏ ở chân mống mắt → thủy dịch đi tắt từ hậu phòng ra tiền phòng, mống mắt **xẹp xuống, góc mở lại**.
- **Phẫu thuật cắt bè củng mạc:** tạo một **đường thoát mới** cho thủy dịch ra dưới kết mạc.

Hình 6. Laser YAG cắt mống chu biên (mũi tên đỏ: thủy dịch đi tắt qua lỗ laser) và phẫu thuật cắt bè củng mạc.

> **Cảnh báo:** cơn glaucoma góc đóng cấp là **cấp cứu nhãn khoa**. Nhãn áp rất cao kéo dài vài ngày có thể làm **mất thị lực vĩnh viễn**. Hạ nhãn áp ngay, rồi chuyển chuyên khoa để làm laser hoặc phẫu thuật.

5. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC MỞ

Dịch tễ và yếu tố nguy cơ

- **Chủng tộc: da đen >> da trắng. Giới:** nữ >> nam.
- **Tuổi:** người lớn tuổi (**60–70%**; **15% người > 80 tuổi**).
- **Di truyền:** nguy cơ **gấp 5–6 lần** nếu có **người ruột thịt mắc bệnh**.
- **Cơ chế: trở ngại lưu thông thủy dịch ở vùng bè** (chưa rõ). Góc vẫn **mở**, nhưng "lưới lọc" thoát kém.
- **Yếu tố nguy cơ khác: nhãn áp khởi điểm cao**, **dao động trong ngày**, **bề dày giác mạc trung tâm mỏng**, **PEX** (hội chứng giả bong bao).

Triệu chứng lâm sàng

- **Cơ năng:**
  - **Xuất hiện âm thầm, tiến triển chậm.**
  - **Thường ở 2 mắt.**
  - **Mờ từ từ, không đỏ, không đau.**
- **Thực thể:**
  - Giảm thị lực; **nhãn áp cao, dao động**, tăng từng lúc.
  - **Soi góc tiền phòng: góc mở.**
  - **Soi đáy mắt: lõm teo gai**, mạch máu bị đẩy **về phía mũi**, **tỉ lệ lõm/đĩa (C/D) ≥ 0,5**.

> **Hiểu nhanh về C/D:** gai thị là chỗ các sợi thần kinh thị tập trung đi ra khỏi mắt; ở giữa có một chỗ lõm sinh lý. Khi sợi thần kinh chết dần, **phần lõm (C) rộng ra so với cả đĩa (D)**. C/D càng lớn, thần kinh thị càng bị tổn thương nhiều.

> **"Kẻ trộm thị lực thầm lặng":** góc mở không đau, không đỏ, mất thị trường từ **ngoại vi vào trung tâm** nên người bệnh không nhận ra cho tới giai đoạn muộn. Người **lớn tuổi, có người thân mắc glaucoma** nên được **đo nhãn áp và soi đáy mắt định kỳ**.

Điều trị

- **Nội khoa (chủ lực):**
  - **Lựa chọn đầu tay: Prostaglandins (Latanoprost) → hạ nhãn áp 30–50%**.
  - **Thuốc ức chế β: Timolol** – lưu ý bệnh nhân **hen suyễn, bệnh tim mạch** (thuốc nhỏ mắt vẫn ngấm vào toàn thân, gây co thắt phế quản, chậm nhịp tim).
  - **Cường α / CAIs:** phối hợp khi cần thiết.
- **Ngoại khoa:**
  - **Tạo hình vùng bè bằng laser Argon.**
  - **Phẫu thuật cắt bè củng mạc**, **đặt valve**.
  - Chỉ dùng khi **nội khoa kém hiệu quả** hoặc **bệnh nhân không tuân thủ** điều trị.

So sánh góc đóng cấp và góc mở

Đặc điểm	Góc đóng cấp	Góc mở
Khởi phát	**Đột ngột, thành cơn**	**Âm thầm, tiến triển chậm**
Triệu chứng	Đỏ, **đau dữ dội**, nhìn mờ, quầng màu, nôn	**Không đỏ, không đau**, mờ từ từ
Soi góc	**Đóng**	**Mở**

Đặc điểm	Góc đóng cấp	Góc mở
Tiền phòng	**Nông**	Bình thường
Đồng tử	**Giãn méo, PXAS (–)**	Bình thường
Điều trị chính	Cắt cơn bằng thuốc → **laser cắt mống chu biên / cắt bè**	**Nội khoa (Prostaglandin) là chủ lực**

6. GLAUCOMA BẨM SINH

- **Tam chứng kinh điển: sợ sáng, chảy nước mắt, co quắp mi**.
- **Thực thể: mắt to (buphthalmos)**, **đục giác mạc**, **đường kính giác mạc > 10 mm**.
- **Bệnh sinh: bất thường màng Barkan**, bất thường cấu trúc góc tiền phòng.
- **Điều trị:** nội khoa **ít tác dụng**; **phẫu thuật mở bè (goniotomy) là chủ yếu**.

Hình 7. Glaucoma bẩm sinh: hai mắt to bất thường; đo đường kính giác mạc giúp chẩn đoán.

Vì sao mắt trẻ lại to ra? Vỏ nhãn cầu của trẻ nhỏ **còn mềm, giãn được**. Nhãn áp cao kéo dài làm nhãn cầu **căng phồng như quả bóng** – điều này không xảy ra ở người lớn vì củng mạc đã cứng.

Ghi nhớ cả bài: thủy dịch **sinh ở thể mi, thoát ở góc tiền phòng**; nhãn áp bình thường **10–21 mmHg**, tăng chủ yếu do **tắc đường thoát**. Góc đóng: **cấp, đau, đỏ, nôn, đồng tử giãn méo** → cấp cứu. Góc mở: **âm thầm, không đau, C/D ≥ 0,5** → điều trị nội khoa lâu dài, **Prostaglandin đầu tay**. Tổn thương thị lực do glaucoma **không hồi phục**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ bài giảng 5. Glaucoma - Diagnosis & Treatment.pdf. Hình minh hoạ lấy từ bài giảng, nhãn đã dịch sang tiếng Việt. Đối chiếu bài giảng gốc khi cần chi tiết.